아급성 갑상선염, 이해하고 끝까지 치료하기

바이러스 감염 후 갑상선에 생기는 통증성 염증 — 4단계 자연경과와 단계별 치료법을 알아봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

아급성 갑상선염 — 세 숫자로 먼저 봅니다

바이러스 감염 뒤 갑상선에 생기는 염증 — 성인 갑상선 통증의 가장 흔한 원인입니다

목 앞쪽이 아픕니다

96%

환자 거의 모두가 목 앞쪽 통증을 겪습니다. 턱·귀·뒷머리로 뻗치기도 합니다.

한쪽에서 시작해 반대쪽으로 옮겨 가기도 합니다.

통증이 가장 큰 단서

여성에게 더 많습니다

4~5배

여성이 남성보다 4~5배 많고, 30~50세 여성에게 흔합니다.

여름~초가을, 장바이러스가 돌 때 더 흔합니다.

감기 뒤 목이 아프면 의심

대부분 회복됩니다

85~95%

12~18개월 안에 기능이 돌아옵니다. 다만 **5~15%**는 기능저하가 남을 수 있습니다.

기능저하가 남아도 호르몬 약으로 정상 생활을 할 수 있습니다.

회복까지 정기 검사

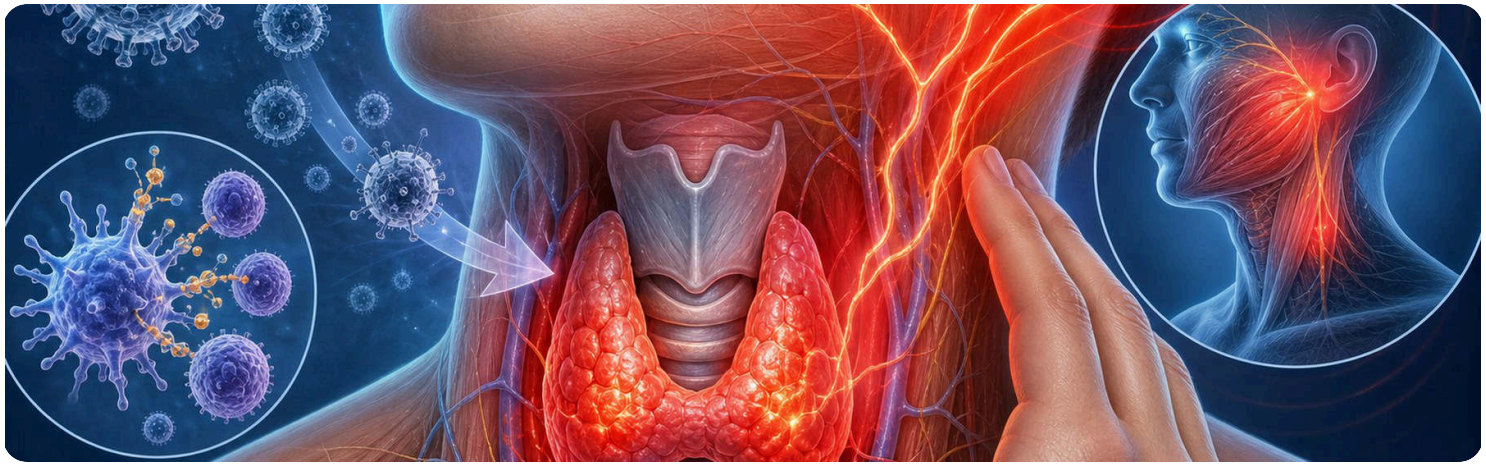
Tip · 감기 등 바이러스 감염 2~8주 뒤에 시작되고, 여름~초가을에 더 흔합니다.

근거 · ATA 2016 권고안 · Stasiak 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 생길까요? — 바이러스 감염이 방아쇠입니다

바이러스가 갑상선을 직접 공격하거나 면역 반응이 지나쳐 갑상선 세포가 깨집니다



이렇게 시작됩니다

감기 등을 앓고 **2~8주 뒤** 목 앞쪽이 아프기 시작합니다. 바이러스가 갑상선 세포를 직접 다치게 하거나, 면역 반응이 지나쳐 세포가 깨집니다.

원인이 되는 바이러스

콕사키·아데노·볼거리·EB 바이러스·코로나19 등 여러 가지입니다.

타고난 체질

특정 유전 표지(HLA-B35)가 환자의 약 **70%**에서 양성으로 나옵니다.

흔한 계절

장바이러스가 도는 **여름~초가을**에 많고, 코로나19 뒤 늘었다는 보고도 있습니다.

그림 · 깨진 세포에 저장돼 있던 갑상선 호르몬이 한꺼번에 피로 새어 나와 두근거림 같은 증상이 생깁니다(설명용 그림).

근거 · Stasiak 2020 · ATA 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

주요 증상 — 네 가지 신호

환자의 96%가 목 앞쪽 통증을 겪고, 약 절반은 두근거림 같은 호르몬 과다 증상이 함께 옵니다



96%

1 목 앞쪽 통증

갑상선 부위가 심하게 아프고 누르면 아픕니다. 턱·귀·뒷머리로 뻗치고, 한쪽에서 반대쪽으로 옮겨 가기도 합니다.

삼킬 때 더 아플 수 있습니다



2 열과 몸살

38~40도의 열, 몸살, 피로가 함께 옵니다. 감기 뒤에 시작해 처음에는 감기가 오래가는 줄로 알기 쉽습니다.

감기와 헷갈리기 쉽습니다



약 50%

3 두근거림·손 떨림

깨진 세포에서 호르몬이 한꺼번에 새어 나와 심장이 빨리 뛰고, 손이 떨리고, 살이 빠지고, 더위를 탑니다.

베타차단제로 다스립니다



4 갑상선이 붓습니다

목 앞쪽 갑상선이 커지고 만지면 단단하고 아픕니다. 한쪽이 더 부어 보이기도 합니다.

림프절은 대개 정상입니다

Tip · 감기가 나은 뒤에도 목 앞쪽이 아프고 열이 이어지면 진료를 받아 보세요.

근거 · Fatourechi · Mayo Clin Proc · ATA 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

자연경과 — 네 단계로 지나갑니다

대부분 6~18개월에 걸쳐 단계적으로 회복됩니다

1 갑상선중독기 · 3~6주

깨진 세포에서 호르몬이 새어 나옵니다. 두근거림·체중 감소·심한 목 통증이 오고 염증 수치가 크게 오릅니다.

2 일시 정상기

호르몬 수치가 잠시 정상이 됩니다. 통증이 나아지고 염증 수치도 차츰 내려갑니다.

3 기능저하기 · 수주~수개월

저장된 호르몬이 바닥나 약 30~50%에서 잠시 기능이 떨어집니다. 피로·체중 증가·추위를 탑니다.

4 회복 · 12~18개월

갑상선이 되살아나 기능이 정상이 됩니다. 85~95%는 완전히 회복하고, 5~15%는 기능저하가 남습니다.



모든 단계를 다 거치지는 않습니다

세 단계를 모두 거치는 분은 약 30%이고, 중독기만 지나고 바로 회복하는 경우도 많습니다.

Tip · 기능저하가 남아도 정기 검사로 일찍 찾으면 호르몬 약으로 정상 생활을 할 수 있습니다.

근거 · ATA 2016 · Sweeney · Am Fam Physician

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단은 어떻게 하나요?

피검사(염증 수치·갑상선 기능)와 영상검사(초음파·방사성 요오드 섭취 검사)를 함께 봅니다

검사	이 병에서 보이는 모습
염증 수치	적혈구 침강 속도(ESR)가 **50 mm/h 넘게** 크게 오르고 C-반응 단백(CRP)도 오릅니다 — 다른 갑상선 병과 가르는 핵심 단서
갑상선 기능 피검사	중독기에는 갑상선 호르몬이 오르고 갑상선 자극 호르몬(TSH)은 눌립니다. 갑상선 자극 항체 검사는 **음성**입니다
방사성 요오드 섭취 검사	**2~5% 미만**으로 거의 잡히지 않습니다 — 35%를 넘는 그레이브스병과 갈립니다
갑상선 초음파	경계가 흐린 어두운 부분과 혈류 감소 — 암과 비슷해 보일 수 있어 **회복 뒤 다시** 봅니다



피검사와 영상검사를 함께 봅니다

한 가지 검사만으로 정하지 않습니다.

Tip · 갑상선 자극 항체가 음성이면 그레이브스병보다 아급성 갑상선염 쪽으로 봅니다.

근거 · ATA 2016 진단 · KTA 갑상선 가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

비슷한 병과 어떻게 구별하나요?

통증이 있는지, 염증 수치, 방사성 요오드 섭취 검사가 그레이브스병·하시모토 갑상선염과 가르는 기준입니다

아급성 갑상선염

목이 **아프고** 염증 수치가 오릅니다.

- 심한 목 앞쪽 통증(96%) — 핵심 단서
- 염증 수치(ESR·CRP) 크게 상승
- 갑상선 자극 항체·갑상선 자가항체 모두 음성
- 방사성 요오드 섭취 매우 낮음(5% 미만)
- 초음파에서 혈류 감소
- 치료 — 소염진통제·스테로이드

vs

그레이브스병 · 하시모토 갑상선염

목이 **아프지 않습니다**.

- 두 병 모두 통증 없음
- 염증 수치 정상
- 그레이브스병 — 갑상선 자극 항체 양성(약 95%)
- 그레이브스병 — 섭취 높음(35% 넘음)
- 초음파 혈류 — 그레이브스병에서 크게 늘어남
- 치료 — 항갑상선제(메티마졸) 또는 경과 관찰

Tip · 두근거림은 같아도 치료가 반대입니다. 그래서 통증과 검사로 먼저 가릅니다.

근거 · ATA 2016 감별 · 통증성·무통성 갑상선염

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료 1단계 — 소염진통제와 베타차단제

가볍거나 중간 정도면 소염진통제로 통증을, 베타차단제로 두근거림·손 떨림을 다스립니다

약	어떻게 먹나요	왜 · 주의할 점
소염진통제	이부프로펜 400~800mg 또는 록소프로펜 60mg, **하루 3회**	가벼운~중간 통증에 먼저 쓰는 약
베타차단제(프로프라놀롤)	10~40mg, 하루 3회 · 중독기(2~6주) **동안만**	두근거림·손 떨림 조절 · 천식이 있으면 다른 약으로 바꿉니다
위 보호제	위장 출혈 위험이 높은 분은 **함께 쓸 수 있습니다**	모든 분이 같이 먹는 약은 아닙니다 — 위험을 보고 정합니다
2~3일 뒤 다시 평가	먹고 2~3일이 지나도 통증이 그대로면	스테로이드(프레드니솔론)로 바꿉니다
쓰지 않는 약	**항갑상선제(메티마졸·PTU)**	호르몬이 새로 만들어지는 게 아니라 깨진 세포에서 새어 나오는 것이라 효과가 없습니다

Tip · 약을 먹어도 통증이 줄지 않으면 참지 말고 2~3일 안에 다시 오세요.

근거 · ATA 2016 치료 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료 2단계 — 스테로이드는 천천히 줄입니다

소염진통제로 부족하면 프레드니솔론을 씁니다 — 천천히 줄여야 재발(약 12%)을 막습니다

1 1~2주차 · 시작

프레드니솔론 20~30mg/일(소론도정 4~6정). 2~3일 안에 통증이 나아지는지 봅니다.

2 3~4주차 · 1차 감량

10~15mg/일(2~3정). 증상이 나아진 것을 보고 차례로 줄입니다.

3 5~6주차 · 최소 유지

5mg/일(1정). 재발하는지 가장 잘 살펴야 하는 때입니다.

4 7~8주차 · 중단

하루걸러 먹다가 끊습니다. 재발하면 이전 용량으로 돌아갑니다.



⚠ 천천히 줄이는 게 원칙입니다

5mg까지 줄이는 데 4주가 안 걸리면 재발이 잦습니다(재발 없던 분 44.3일 · 재발한 분 19.0일). 좋아졌다고 **혼자 끊지 마세요** — 갑자기 끊으면 부신 위기가 올 수 있습니다.

그림 · 용량을 한 단계씩 줄여 가는 모습(설명용 그림) — 줄이는 속도는 담당 의사가 정합니다.

근거 · ATA 2016 · Sato · Endocr J 2017

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

바로 알려야 할 위험 신호

치료 중 아래 증상이 나타나면 약을 임의로 조절하지 말고 바로 진료를 받으세요

갑상선 폭풍 의심 — 응급 상황

38도 이상 열에 분당 130회 넘는 맥박 · 의식이 흐려짐 · 심한 구토 중 하나라도 겹치면, 또는 열이 없어도 의식이 흐려지거나 이 증상이 여럿이면 **바로 응급실**로 가세요.

스테로이드를 혼자 끊었을 때

좋아졌다고 혼자 끊으면 부신 위기(심한 저혈압·쇼크)가 올 수 있습니다. 의사 지시대로 천천히 줄이세요.

스테로이드 2~3일에도 통증이 그대로

먹고 48~72시간 안에 통증이 뚜렷이 줄지 않으면 진단을 다시 봐야 합니다 — **바로 다시 오세요**.

회복 뒤 기능저하가 남을 때(5~15%)

회복 뒤에도 6~12개월간 갑상선 기능검사를 받으세요. 피로·추위 탐·체중 증가가 이어지면 호르몬 약(레보티록신)이 필요합니다.

Tip · 밤이나 주말이라도 첫 번째 줄의 증상이면 기다리지 말고 응급실로 가세요.

근거 · ATA 2016 응급 감별 · KTA 갑상선기능저하증 권고안

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

대부분 회복됩니다 — 꾸준한 복약과 경과 관찰이 회복의 핵심입니다

01 바이러스 감염 뒤 생기는 염증 — **85~95%**는 12~18개월 안에 회복합니다

02 목 앞쪽 통증이 핵심 — 그레이브스병은 아프지 않습니다

03 가벼운 통증은 소염진통제(부루펜·록소닌) — 위장 출혈 위험이 높으면 위 보호제를 함께

04 두근거림·손 떨림은 프로프라놀롤(인데랄)로 다스립니다

05 중간~심한 통증은 프레드니솔론을 6~8주에 걸쳐 줄입니다 — **혼자 끊지 않기**

06 2~3일 안에 통증이 안 줄면 **바로 다시 진료** — 진단을 다시 봅니다

07 갑상선 기능검사(TSH)를 6~8주 간격으로 받습니다

08 피로·추위 탐·체중 증가가 생기면 알려 주세요

Tip · 이 장을 사진으로 찍어 두고, 다음 진료 때 궁금한 번호를 말씀해 주세요.

근거 · ATA 2016 권고안

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대부분 회복됩니다 — 정기 검사로 끝까지 함께합니다

궁금한 점이 있으시면 언제든지 상담해 주세요 — QR로 같은 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

회복 뒤에도 검사는 이어집니다

대부분 회복되지만 일부(5~15%)는 갑상선 기능저하가 남아 약이 필요할 수 있습니다. 정기 검사로 끝까지 함께 확인합니다.

이 자료의 성격

아급성 갑상선염을 진단받은 분을 위한 설명자료입니다. 다른 원인은 항진증 자료를 봅니다.

QR 코드

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

Tip · 치료가 끝난 뒤에도 피로·추위 탐·체중 증가가 생기면 알려 주세요.

근거 · ATA 2016 · KTA 갑상선기능저하증 권고안